

Secuelas cognitivas del COVID-19

Luisa Vidal





Infección por COVID-19

- El SARS-CoV2 causa distintas manifestaciones clínicas agrupadas bajo el término COVID-19
- La presentación clínica más frecuente es la infección respiratoria aguda
- Combinación de factores de la infección y del **aislamiento social**



Síntomas como fiebre, tos seca, disnea, mialgias, cefalea y diarrea

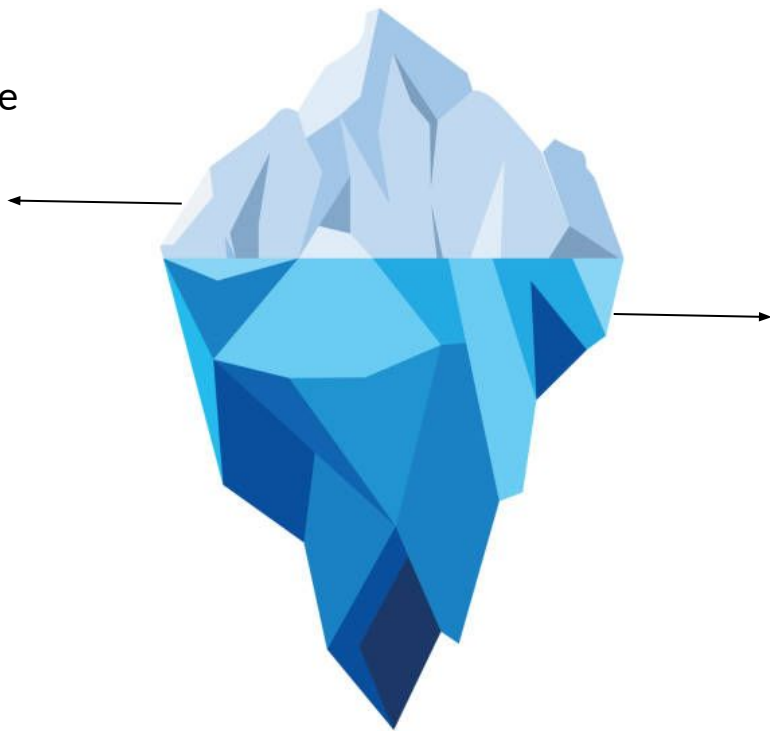


Varía desde un resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con **distrés respiratorio**



Progresión del COVID-19

Pacientes que en la fase aguda sufren graves complicaciones



Long COVID: pacientes que más allá de la afectación aguda, no recuperan su estado vital previo

- Presente 3 meses después de la infección y puede mantenerse hasta 2 años después
- Afectan las actividades cotidianas
- No se explica por otras causas



Niebla mental

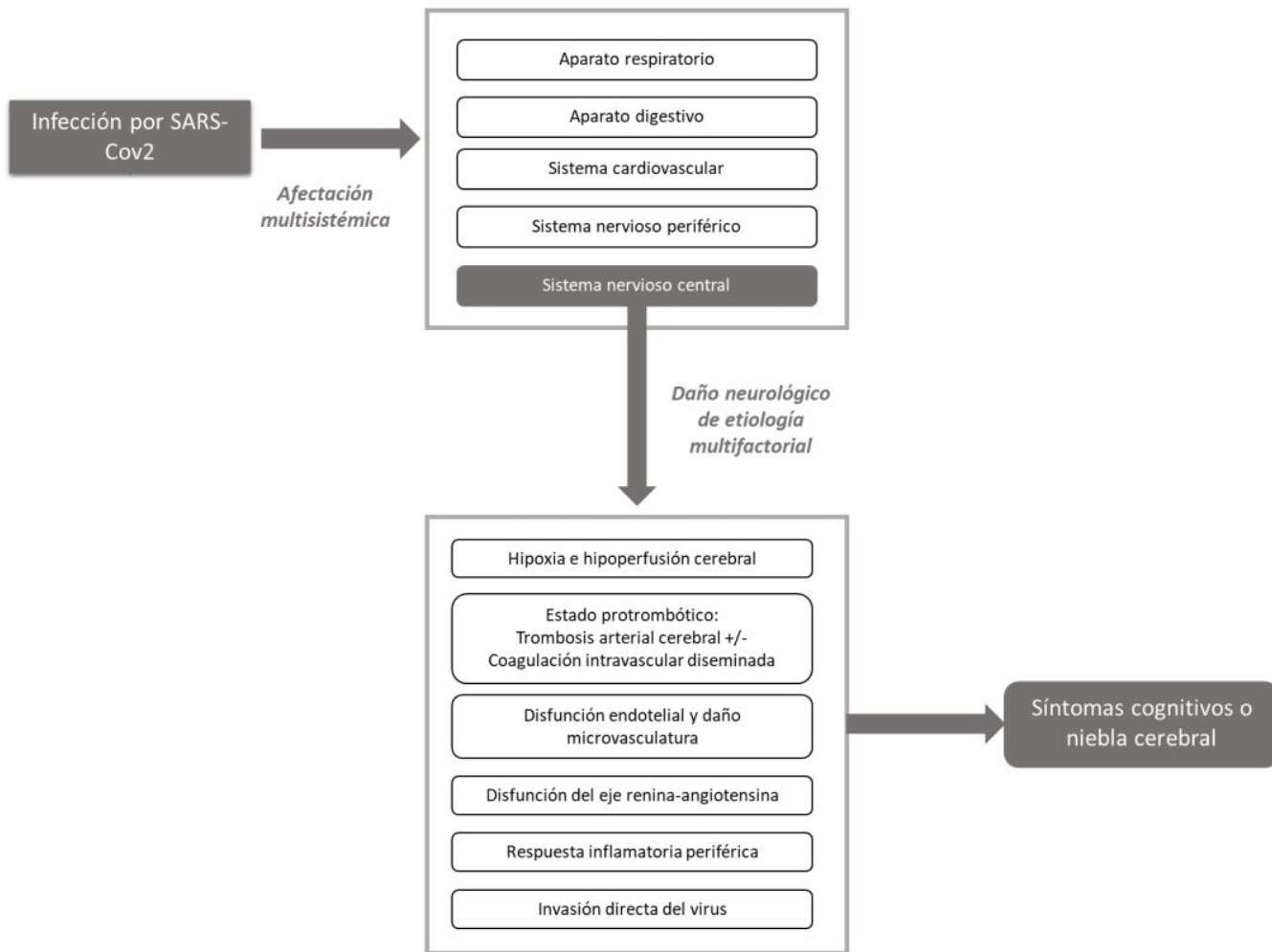
“Conjunto de signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección por COVID-19, continúan por más de 12 semanas y no son explicados por otro diagnóstico”

- **Falta de atención:** dificultades para concentrarse
- **Pérdida de memoria a corto plazo:** olvidos de citas, reuniones, entregas laborales, etc.
- **Pérdida de la agudeza mental:** lentitud y fatiga





AFECTACIÓN MULTISISTÉMICA



Perfil cognitivo post-COVID



- El dominio más afectado es el de **funciones ejecutivas**
- Utilizando el MoCA, el MMSE y el CPT se han encontrado dificultades en **atención, planificación, lentificación de la velocidad de procesamiento, peor memoria a corto plazo, disminución en la capacidad de abstracción y en la orientación.**

(Altuna et al., 2024)

Síntomas cognitivos
Cognición global
Concentración
Memoria:
Memoria de trabajo
Memoria episódica verbal
Memoria visual
Función ejecutiva:
Atención sostenida
Velocidad de procesamiento
Procesamiento visuoespacial
Lenguaje
Síntomas afectivos
Ansiedad
Depresión
Trastorno por estrés postraumático
Síntomas conductuales
Irritabilidad
Alteración del sueño
Otros síntomas
Fatiga



Perfil cognitivo post-COVID

Muestra de pacientes con COVID-19 persistente, evaluados con pruebas del proyecto Neuronorma España y WAIS-IV:

- Principales dificultades en **velocidad de procesamiento**.
- **Funciones ejecutivas**: especialmente en la capacidad de inhibición y resolución de problemas.
- Problemas en la capacidad de recuperar información verbal

El 88% de los participantes mostraron deterioro cognitivo de diferente gravedad.



Paciente con COVID leve

Cursa de forma asintomática o con síntomas pseudogripales leves.

En personas entre los 30 y los 60 años se han encontrado:

- **Disfunción ejecutiva.**
- **Disfunción mnésica leve**, tras al menos tres meses después de la infección.

Síntomas de niebla cerebral



- Inicio a partir de la primera semana, con pico máximo a los 3 meses.
- Síntomas persistentes hasta el séptimo mes
- Empeoramiento del rendimiento laboral



Paciente con COVID grave

- Distrés respiratorio grave: factor importante para el desarrollo de síntomas cognitivos
- **Delirium** en fase aguda se puede presentar en el 30% de pacientes ingresados = invasión directa del SNC por SARS-Cov2
- Las personas con estancia en UCI presentan en mayor frecuencia TEPT, ansiedad y depresión

Dx diferencial



- **Momento de aparición de los síntomas:** ¿funcionamiento normal previo al COVID-19? ¿los síntomas cognitivos aparecieron después de la infección?
- **Antecedentes:** gravedad del COVID, hospitalización - UCI, vacunas, uso de oxígeno, enfermedades previas, enfermedades familiares, medicamentos, hábitos, edad, ocupación, nivel educativo, etc.
- **Evaluación longitudinal** para saber el curso de las dificultades





Referencias

- Altuna, M., Sánchez-Saudinós, M. B., & Lleó, A. (2024). Síntomas cognitivos post-COVID. Sant Pau Memory Unit, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Biomedical Research Institute Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona, Centre of Biomedical Investigation Network for Neurodegenerative Diseases (CIBERNED). Recuperado de <http://www.elsevier.es>
- Domínguez-Paredes, A. L., Varela-Tapia, C. L., Dorado-Arias, V., Salazar-Núñez, E., & Martínez-Barro, D. (2023). [Cognitive alterations in patients recovered from COVID-19 treated in Cardiopulmonary Rehabilitation]. PubMed, 61(6), 796–801. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10064351>
- Ortiz Sánchez, F. (2019). Guía clínica para la atención al paciente LONG COVID/COVID persistente. Semg.es. <https://www.semg.es/index.php/consensos-guias-y-protocolos/363-guia-clinica-para-la-atencion-al-paciente-long-covid-covid-persistente>
- Pérez Sánchez, M. C. (2022). La influencia de los padres en el rendimiento académico de los hijos. [Master's thesis, Universitat Oberta de Catalunya]. UOC O2 Repository. <https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/139907/6/mcpersanchezTFM0122memoria.pdf>
- Rodríguez Rodríguez, E., Gómez Gómez-Acebo, F., Armenteros del Olmo, L., Rodríguez Ledo, M. P., & el Comité Científico. (2021). Guía Clínica para la atención al paciente Long COVID / COVID Persistente (Versión 1.0). @longcovidACTS. <https://example.com>